Psicopatología de la audición y el lenguaje

Unidad 5. Psicopatología de la audición y el lenguaje en el alumnado con NEAE

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE 1
INTRODUCCIÓN 2
EL ALUMNADO CON DIFERENTES REALIDADES DENTRO DEL MARCO EDUCARTIVO DE LA LOMLOE 3
Sección 2.1 Introducción 3
Sección 2.2 Retraso madurativo 3
Sección 2.3 Altas capacidades intelectuales 4
Sección 2.4 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 7
Sección 2.5 Otro alumnado 10
RESUMEN DEL TEMA 13
GLOSARIO 15
BIBIOLOGRAFÍA 17

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se abordará la conceptualización y las características lingüísticas de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo relacionadas con altas capacidades, dificultades de atención e hiperactividad o derivadas de una incorporación tardía o unas dificultades de acceso en el sistema educativo español. Condiciones que pueden desencadenar problemas de aprendizaje o de comunicación y lenguaje. De este modo, se podrá analizar de otra manera las dificultades de este alumnado sujeto a diversas realidades, así como la organización de apoyos y recursos materiales y personales.

Partiendo de este concepto, se entiende la escuela como un sistema amplio e inclusivo dónde se debe conseguir el desarrollo pleno de todos los alumnos. Los problemas o dificultades de aprendizaje o de comunicación y lenguaje no siempre tienen que estar ligados a una discapacidad, por eso se amplía el radio de intervención a todos estos alumnos que necesitan un apoyo educativo específico y diferente al ordinario.

EL ALUMNADO CON DIFERENTES REALIDADES DENTRO DEL MARCO EDUCARTIVO DE LA LOMLOE

Sección 2.1 Introducción

La LOMLOE es la actual ley educativa, aprobada a final de 2020. En dicha normativa se cuenta con un Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dentro de este artículo, el apartado Cuarenta y nueve, se centra en la modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 71 de la LOE quedando la redacción en los siguientes términos:

"Por presentar necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los Objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado" (LOMLOE, 2020)

Sección 2.2 Retraso madurativo

2.2.1 Conceptualización

Haciendo referencia al DSM-5 (2013), el Retraso Madurativo recibe el nombre de Retraso Global del Desarrollo, el cual se experimenta en niños menores de 5 años que no alcanzan los hitos de desarrollo propios de su edad en diferentes campos del funcionamiento intelectual (Vijande, 2021).

Es un trastorno en el desarrollo que aparece en los primeros años de vida, dicho desarrollo procede de la maduración del sistema nervioso, la cual supone la adquisición de habilidades comunicativas, motrices, cognitivas, emocionales y sociales (Álvarez et al., 2019). En condiciones típicas, esas habilidades se van desarrollando acorde a la edad, pero ante un Retraso Madurativo no ocurre eso, es decir, se produce un retraso en una o varias áreas de desarrollo y el sujeto no cumple con los hitos propios de su edad, sino que muestra características correspondientes a niños de una edad cronológica menor.

En suma, en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), el Retraso Madurativo recibe el nombre de falta de desarrollo fisiológico normal esperado y supone el retraso de los hitos del desarrollo, así como en el desarrollo fisiológico normal (desarrollo motor grueso y fino, adquisición del lenguaje y sociabilidad).

2.2.2. Etiología

En cuanto a los rasgos característicos generales que presentan los niños con este problema podemos señalar las siguientes (Vijande, 2021):

- Dificultad en las relaciones sociales (interacción con los demás).
- Les cuesta establecer hechos, variedades, clasificaciones y relaciones entre los objetos.

- El nivel de motivación en las actividades se ve condicionado por la escasa comprensión verbal, falta de hábitos de atención establecidos o dificultad en la tarea propuesta.
- Dificultades para reorganizar y entender las demandas sociales.
- Inconvenientes para mantener y dirigir la atención.
- Problemas para organizar la información y adaptar la conducta.

2.2.3. Áreas afectadas

El Retraso Global del Desarrollo puede afectar a varias áreas del desarrollo infantil, incapacitando al individuo para desarrollar las destrezas propias de cada una de ellas, estas suelen estar relacionadas con (Álvarez et al., 2019):

- La motricidad (fina y/o gruesa).
- El lenguaje y el habla.
- Las funciones cognitivas.
- El desarrollo personal y social.
- Las actividades de la vida cotidiana.

Puede presentarse en el aula de diversas formas, es decir, depende del nivel de dificultad que presente, normalmente el niño con dicho diagnóstico está capacitado para aprender y desarrollar sus tareas, aunque a un ritmo más lento, pero por esto no se le debe considerar incapaz (Vijande, 2021). Estos alumnos necesitan que sus tiempos y características sean respetados, ofreciéndoles la libertad que necesitan para aprender a su ritmo en el tiempo que necesiten y sin presiones.

Sección 2.3 Altas capacidades intelectuales

Cada persona posee su propio cociente intelectual que, en la gran mayoría, se sitúa dentro del rango de la normalidad, el resto se encuentra por debajo o por encima de la media, este último caso es el de los individuos con Altas Capacidades Intelectuales (Mateos et al., 2006). En consonancia con lo mencionado anteriormente, para el Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades (https://www.altascapacidadescse.org/), las ACI deben ser estudiadas desde una nueva perspectiva que tenga en cuenta tanto las características cognoscitivas como las emocionales.

Tal y como evidencia la AEST (Asociación Española de Superdotados y con talento para niños, adolescentes y adultos) en su página oficial https://www.aest.es/, siguiendo el modelo de Castelló y Batlle (1998), se entiende como Alta Capacidad Intelectual (ACI) el perfil del alumnado que dispone de una capacidad intelectual globalmente situada por encima del percentil 75 en todos los ámbitos de la inteligencia tanto convergente como divergente, incluyendo distintas aptitudes intelectuales, como pueden ser razonamiento verbal, razonamiento lógico, memoria, creatividad, y razonamiento fluido.

Este modelo también incluye el *perfil de talento simple*, que se refiere al alumnado que muestra una elevada aptitud o competencia en un ámbito específico, por encima del percentil 95, como el verbal, matemático, lógico o creativo, entre otros; así como la combinación de varias aptitudes específicas que puntúan por encima de un percentil 80 dando lugar a talentos complejos.

Así, en base lo anterior, se evidencia que Altas Capacidades Intelectuales, es un término algo difuso, que engloba casos más específicos y excepcionales como la superdotación y el talento.

En lo que respecta a la superdotación/sobredotación intelectual, la persona que la presenta se caracteriza por contar con una superioridad intelectual, la cual es evaluada con una batería de prueba a los que se añade madurez social y emocional superiores, salud física y creatividad.

Conjuntamente, tal y como afirma Benito (1992); en Sánchez (2013), se deberá también valorar la originalidad de sus trabajos, su rápida orientación, concentración, interés por diversos temas y el desempeño sobresaliente.

Por su parte, el talento es el fenómeno cognoscitivo y emocional de la inteligencia humana que, en parte, es opuesto al concepto de superdotación/sobredotación en cuanto a lo que a especificidad y diferencias cuantitativas se refiere. Este puede ser, tal y como apunta Sánchez (2011), simple, referido a quienes tienen una elevada aptitud o competencia en un ámbito específico (verbal o matemático) o en un tipo de procesamiento cognitivo (lógico o creativo), o complejo, el cual hace referencia a aquellos que presentan una combinación de varias actitudes específicas (talento matemático, resultado de la combinación entre aptitud verbal, razonamiento lógico y gestión memorística).

Así pues, la inteligencia es concebida, por tanto, como un conglomerado de aptitudes donde cada persona puede tener una alta capacidad en una aptitud específica y no en otra, de ahí que se hable de sobredotación/superdotación y de talento, en función de que se sea bueno en todas las áreas, en una o en varias específicas (Sternberg, 1993; en López, 2012).

En lo que se refiere a términos de diagnóstico, el criterio fundamental, como ya se adelantó anteriormente, que clásicamente se utilizó fue el poseer una inteligencia superior a la media. Esta idea fue asumida sin discusión, hasta que algunos expertos denunciaron que el CI no podía ser el único factor a tener en cuenta (Ovalles, 2017).

Actualmente, el término de ACI se ha ido matizando hasta obtener un concepto más dinámico, llegándose así a un acuerdo respecto a que, para establecer el diagnóstico de sobredotación/superdotación intelectual es necesario que la persona cumpla con tres criterios fundamentales interrelacionados, con base en la teoría de los tres anillos de Renzulli (2000).

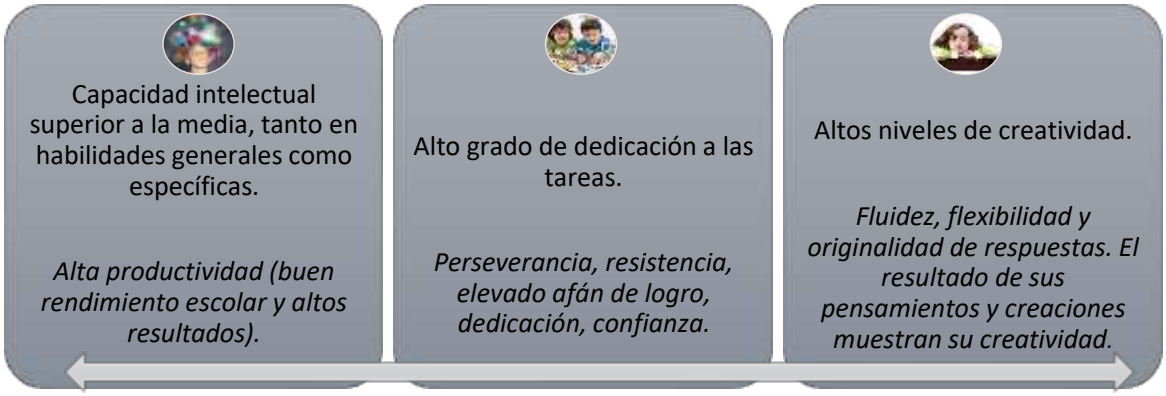


Ilustración 1. Teoría de los tres anillos de Renzulli (Ovalles, 2017)

Las ACI, con unas características, según el Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades (https://www.altascapacidadescse.org/), de gran heterogeneidad (véase Tabla 1), son consideradas, por tanto, la expresión máxima de la inteligencia humana y el resultado de la interacción de una serie de factores, que pueden ser variables en cada uno, con una serie de circunstancias ambientales favorecedoras de la aparición precoz de esas capacidades, todo ello dentro de un proceso de maduración neurológico continuado (Campos, 2002, en Aretxaga, 2013).

Tabla 1.
Nuevo paradigma de la superdotación y las Altas Capacidades Intelectuales según el Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades (Sánchez, 2013)

Características del nuevo paradigma de las Altas Capacidades Intelectuales
• Interrelación entre las aptitudes específicas de la persona y el diferente desarrollo y configuración morfológica de su cerebro.
• Las personas con ACI constituyen el mayor capital humano para una sociedad siempre que reciban una educación adecuada.
• En el diagnóstico de los estudiantes con ACI deben participar profesionales con competencias no solo educativas.
• La precocidad intelectual. Fenómeno evolutivo, cognoscitivo y emocional de la inteligencia humana que se produce a lo largo del desarrollo, desde el nacimiento hasta los catorce años, gracias a la activación de los recursos intelectuales básicos.
• El síndrome de disincronía. Hace referencia al desfase que puede producirse entre diferentes niveles de desarrollo, por ejemplo, el intelectual y el emocional, como consecuencia del desarrollo heterogéneo específico de aquellos que presentan ACI. Este desfase tiene como resultado la aparición de problemas de identificación y aprendizaje.
• El diagnóstico clínico integrado. Análisis clínico de las características de la persona, es decir, en sus valores y aptitudes, así como en sus problemas, debilidades y necesidades emocionales y cognitivas.

En términos de prevalencia e identificación, según los datos arrojados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre el curso 2018/2019, solo se tienen identificados 35.494 alumnos de enseñanzas no universitarias con ACI (4%), de los 8.217.662 alumnos en total escolarizados en España, lo cual representa un porcentaje de apenas el 0,43 % del total. Con todo, faltarían, por tanto, por identificar 129.498 (96%) alumnos a nivel nacional.

Finalmente, en cuanto a las características lingüísticas de los alumnos con altas capacidades, podemos señalar las siguientes:

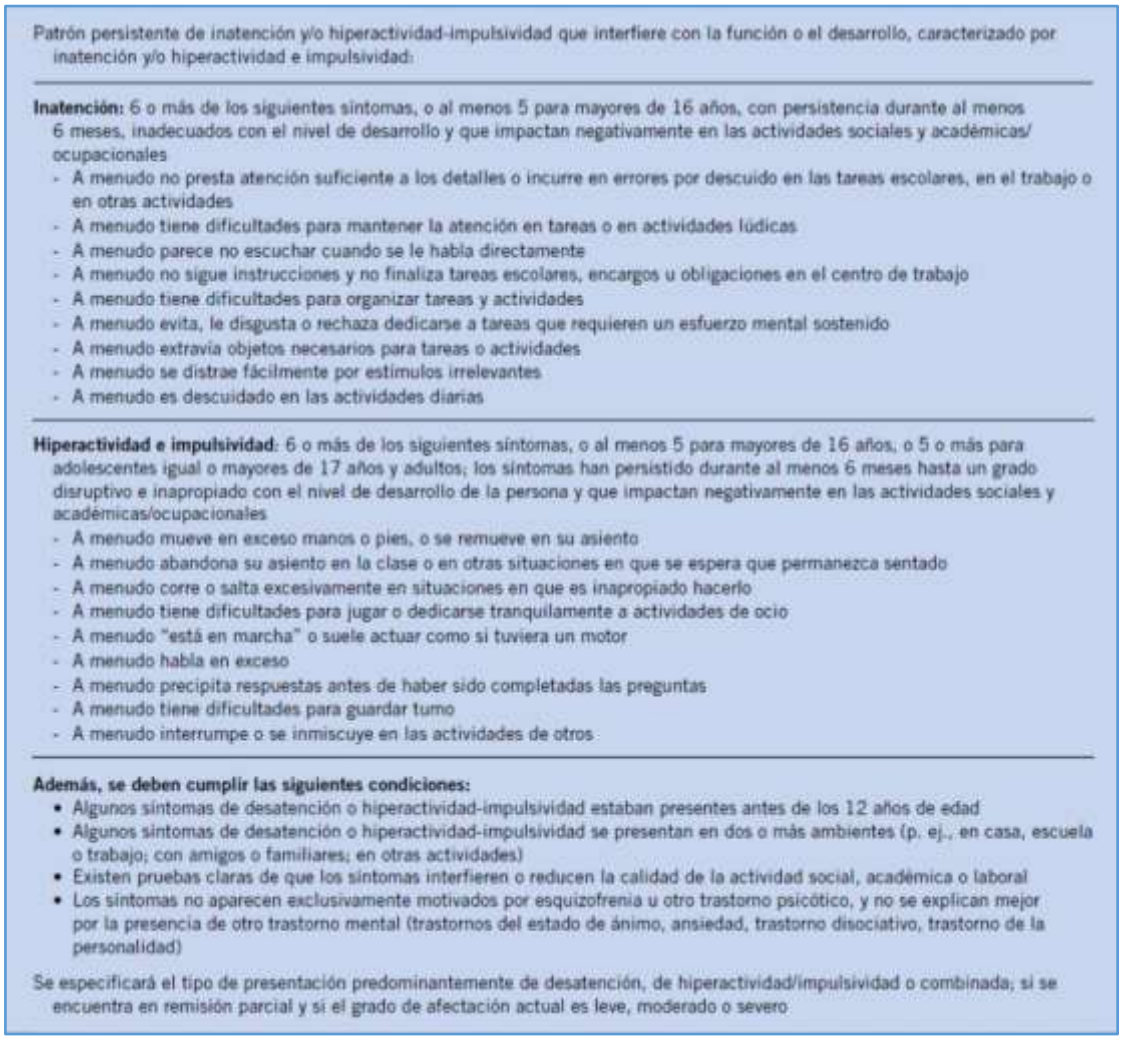
- Adquisición temprana del lenguaje.
- Vocabulario extenso y amplio.

- Facilidad para comprender el doble sentido y la ironía.
- Comprenden sin dificultades el lenguaje y pueden mantener conversaciones de adultos.
- Adquisición de la lectura rápidamente.
- Facilidad para expresar sus emociones e ideas.
- Habilidad para deletrear.
- Utilizan frases complejas y con una estructura correcta.
- Gran creatividad lingüística.
- Correcta articulación de los fonemas.
- Dificultades a nivel pragmático debido a centro de interés diferente a otros alumnos de su edad.

Sección 2.4 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad

2.4.1. Concepto

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se define como un trastorno del desarrollo neurológico que se caracteriza por síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad que son inconsistentes con el nivel de desarrollo y que repercuten de manera negativa en las actividades sociales y académicas (DSM-5, 2013). Es considerado de carácter heterogéneo, dada la diversidad de su grado de afectación y su posibilidad de combinación con otras patologías, en cuyo caso será fundamental, por parte del profesorado, conocerlas y diferenciarlas para ayudar al alumnado a mejorar su calidad tanto de vida como educativa (Ilustración 2).



Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con la función o el desarrollo, caracterizado por inatención y/o hiperactividad e impulsividad:

Inatención: 6 o más de los siguientes síntomas, o al menos 5 para mayores de 16 años, con persistencia durante al menos 6 meses, inadecuados con el nivel de desarrollo y que impactan negativamente en las actividades sociales y académicas/ ocupacionales

- A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades
- A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas
- A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente
- A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el centro de trabajo
- A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades
- A menudo evita, le disgusta o rechaza dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido
- A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades
- A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes
- A menudo es descuidado en las actividades diarias

Hiperactividad e impulsividad: 6 o más de los siguientes síntomas, o al menos 5 para mayores de 16 años, o 5 o más para adolescentes igual o mayores de 17 años y adultos; los síntomas han persistido durante al menos 6 meses hasta un grado disruptivo e inapropiado con el nivel de desarrollo de la persona y que impactan negativamente en las actividades sociales y académicas/ocupacionales

- A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento
- A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado
- A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo
- A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio
- A menudo "está en marcha" o suele actuar como si tuviera un motor
- A menudo habla en exceso
- A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas
- A menudo tiene dificultades para guardar turno
- A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros

Además, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Algunos síntomas de desatención o hiperactividad-impulsividad estaban presentes antes de los 12 años de edad
- Algunos síntomas de desatención o hiperactividad-impulsividad se presentan en dos o más ambientes (p. ej., en casa, escuela o trabajo; con amigos o familiares; en otras actividades)
- Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren o reducen la calidad de la actividad social, académica o laboral
- Los síntomas no aparecen exclusivamente motivados por esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (trastornos del estado de ánimo, ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad)

Se especificará el tipo de presentación predominantemente de desatención, de hiperactividad/impulsividad o combinada; si se encuentra en remisión parcial y si el grado de afectación actual es leve, moderado o severo

Ilustración 2. Criterios diagnósticos del TDAH especificados en el DSM-V (2013)

Siguiendo a Schroeder y Gordon (2002), podría añadirse que su origen, aunque no está completamente claro, se encuentra en el desequilibrio entre dos neurotransmisores cerebrales, dopamina y noradrenalina, que afectan a las áreas del cerebro encargadas del autocontrol y de la inhibición de las conductas no deseadas, ocasionando este hecho un alto grado de actividad, impulsividad y falta de atención en el alumnado que no se corresponde con el nivel de desarrollo adecuado a otros factores (i.e., la edad). Así pues, todo lo anteriormente mencionado provoca numerosas alteraciones en los procesos de aprendizaje y puede llegar a perjudicar notablemente el desarrollo educativo tanto dentro como fuera del aula.

En lo que respecta a la tipología, tal y como avala el DSM-5 (2013), existen diferentes variedades de TDAH: predominante inatento, predominante hiperactivo-impulsivo y presentación combinada. Todos los subtipos se reconocen bajo la misma etiqueta, aunque, por ejemplo, un alumno presente solo déficit de atención o predomine en él tan solo el subtipo hiperactivo. Dentro de lo mencionado, el subtipo más predominante en el campo educativo es el inatento, aunque, si bien es cierto que el combinado es el más diagnosticado. Balbuena (2016) y Vieites

(2019) coinciden con lo expuesto señalando que la presentación inatenta es hasta dos veces más frecuente que la combinada en la edad escolar .

Por último, también debe tenerse en cuenta que el TDAH afecta a nivel madurativo cerebral y a los procesos cognitivos del cerebro. Así pues, la mayoría de los síntomas y comportamientos de los estudiantes con este trastorno son consecuencia de dificultades en los procesos cognitivos, perceptivos y neurobiológicos (Artigas y Narbona, 2011). El alumnado con TDAH muestra, por tanto, una mayor rigidez cognitiva en el procesamiento de la información, es decir, una flexibilidad cognitiva menor.

2.4.2. Alteraciones en la atención y memoria del alumnado con TDAH

El funcionamiento atencional del alumnado con TDAH es diferente al del resto de los estudiantes, pues presentan dificultades para mantener la atención ante una tarea o estímulo y responder adecuadamente, sobre todo si son actividades poco motivadoras, dificultades en la rapidez del procesamiento de la información y en la atención selectiva o focalizada y dificultades en la atención dividida o alternante (Guerrero, 2016).

En cuanto a la atención voluntaria, presentan dificultades para mantenerla dado que depende de las funciones ejecutivas y, por supuesto, de la motivación externa recibida a la hora de poner en marcha la realización de alguna actividad que la requiera (Macià, 2012).

A lo anterior, Alsina y Sáiz (2003) añaden que para los estudiantes con TDAH es más difícil focalizar y mantener la atención que llevar a cabo tareas que requieran la implicación de, por ejemplo, la memoria de trabajo, pues cuanto menor es la velocidad de procesamiento, menor es la duración de la información en este tipo de memoria, proceso que junto con la atención es esencial para lograr concentración en las operaciones cognitivas y actividades intencionales.

Por último, en relación con la atención, es importante señalar que, aunque este alumnado no presente dificultades en ningún tipo de atención involuntaria, pues suelen prestar atención a todo tipo de estímulos que haya a su alrededor, sí puede hablarse de problemas de orientación y focalización atencional de la memoria operativa, componente que controla y supervisa los sistemas subsidiarios verbal y visoespacial, (Barkley, 2006).

En lo que respecta a la memoria, el alumnado con TDAH posee dificultades en la habilidad de retener en la mente aquella información necesaria para guiar las acciones, recordar hacer cosas en un futuro cercano, memorizar y seguir instrucciones, recordar una información mientras trabaja en otra y, también, dificultad para manipular y transformar la información que almacena al servicio de guiar su conducta hacia un objetivo concreto (Díaz et al., 2013).

Los estudiantes con TDAH, a la luz de investigaciones como la de García et al., (2001), tienen dañadas sus habilidades amnésicas, es decir, tienen dificultades en la memoria de trabajo (capacidad de mantener y manipular por un corto periodo de tiempo la información necesaria para guiar una determinada conducta) y en la memoria a corto plazo, ambas se encuentran directamente relacionadas. En relación con esto, cabe destacar que la memoria a corto plazo no se encuentra tan afectada en este alumnado como la memoria de trabajo, la cual es un subtipo dentro de la primera y se diferencia de ella en que no solo almacena información, sino que también opera con ella para llegar a un resultado o meta (Enseñat, 2015).

Por su parte, en cuanto a la memoria a largo plazo, la memoria declarativa está en mayor medida afectada que la memoria implícita o no declarativa. De este modo, el rendimiento obstruido en la memoria declarativa puede venir dado tanto por un déficit de codificación-consolidación de la información como por una mala recuperación de la información almacenada. En lo que respecta a la no declarativa, el aprendizaje incidental se encuentra preservado y el aprendizaje procedimental es más lento y con mayor número de errores.

En definitiva, se puede afirmar que en el alumnado con TDAH se encuentra presente un déficit atencional asociado a otras alteraciones cognitivas como la memoria y que para su mejora es necesaria una intervención cognitiva y psicoeducativa que entre y mejore ambos procesos cognitivos desde una perspectiva integral (Vieites, 2019).

2.4.3. Características lingüísticas

Según Fuente (2016), algunas de las principales características que presentan los alumnos con TDAH son las siguientes:

- Falta de vocabulario.
- Falta de coherencia y cohesión en el discurso. Se caracteriza por alterar el orden cronológico y omitir partes de este.
- La prosodia en el discurso suele verse alterada con cambios de tono constantes.
- A nivel fonético – fonológico comente omisiones, adicciones o sustituciones de fonemas.
- Falta de escucha activa.
- Monotonía en el discurso, siempre hablan de lo mismo.
- Dificultad para expresar sus sentimientos y emociones.
- Dificultad para respetar los turnos de palabra. Suelen interrumpir.
- Falta de argumentos para defender sus ideas.

Sección 2.5 Otro alumnado

2.5.1. Incorporación tardía al sistema educativo

Se considera que un alumno o alumna presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración Tardía en el Sistema Educativo» cuando, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se escolariza de forma tardía y presenta problemas para acceder a la adquisición de los objetivos y competencias básicas respecto a sus coetáneos (Sáez, 2021).

A este alumnado se le proporciona respuesta a través de la medida de apoyo idiomático y las aulas de acogida.

2.5.1.1. Apoyo idiomático

Esta medida se establece con la finalidad de favorecer la superación de la barrera idiomática y mejorar la competencia comunicativa del alumnado no hispanohablante matriculado en alguno de los cursos de la enseñanza básica, de forma que se facilite el acceso al currículo ordinario (Torre, 2008).

Propicia la elaboración y puesta en marcha del protocolo de acogida: ambientación del centro, elaboración de carteles en diversos idiomas, consensuar un protocolo de acogida del nuevo alumnado, familias, participar en la comisión de convivencia…Potencia la coordinación y colaboración con proyectos, organizaciones, asociaciones tanto del propio centro como del entorno que favorezcan la integración y la educación para el desarrollo, la solidaridad y la ciudadanía (Sáez, 2021).

2.5.1.2. Aulas de acogida

Pretende la acogida e integración escolar y social del alumnado inmigrante en nuestra sociedad y su adaptación a nuestro sistema educativo. El trabajo en estas aulas propiciará la adquisición del español como lengua vehicular de sus nuevos aprendizajes y relaciones sociales; el conocimiento e integración en los usos y costumbres de la sociedad que los acoge, y los aprendizajes curriculares de cada una de las áreas y competencias básica del grupo de referencia que, por edad, corresponde a cada uno de estos alumnos en *el* sistema educativo (Torres, 2008).

Estas aulas constituyen un recurso organizativo y metodológico adaptado a las necesidades del alumnado lingüística y culturalmente diverso, por tanto, individualizado y flexible en cuanto a la respuesta que ha de dar al alumnado escolarizado en el segundo y el tercer ciclo de Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria.

2.5.2. Dificultades de acceso al sistema educativo por condiciones personales e historial escolar

Se considera alumnos con dificultades de acceso al sistema educativo cuando tiene un desfase temporal de al menos dos cursos en primaria, y su referente curricular está, tanto en objetivos como en contenidos, situado junto con los alumnos de su edad. Estas dificultades o problemas no están asociados a discapacidad intelectual, trastornos graves de conducta, ni trastorno generalizado del desarrollo, ni déficit de atención con o sin hiperactividad (López y Valenzuela, 2015).

Estas dificultades tienen que ser derivadas o consecuencia de problemas socioculturales, incorporación tardía al sistema escolar, problemas de salud, dificultades del habla, del lenguaje, o la comunicación o combinación de ambos.

- Una incorporación tardía al sistema escolar por ausencias continuas, absentismo escolar por distintas causas, cambios de ciudad…
- Problemas de acceso a la cultura: en la mayoría de las ocasiones por vivir en contextos con bajos recursos económicos.

- Problemas de salud: debido a largas temporadas hospitalizados, tratamientos agresivos o a problemas de tipo cognitivo o neuropsicológico que provocan retrasos en el avance de los contenidos propios de su edad.
- Problemas de comunicación, habla o lenguaje: que provocan alteraciones en el desarrollo normal de los patrones comunicativos y afectan a las diferentes dimensiones del lenguaje. Los más comunes suelen ser retraso del lenguaje, disfemias, dislalias, disglosias o trastornos del habla.

Para poder compensar estas dificultades, en función de dónde derive el problema se tomarán algunas de las medidas educativas plasmadas en el punto anterior y en lo referido a la comunicación se tratarán con las pautas de intervención en función del tipo de trastorno del habla, comunicación o lenguaje que sea.

RESUMEN DEL TEMA

La Unidad 5 aborda las características del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) relacionadas con el retraso madurativo, las altas capacidades intelectuales, el TDAH, la incorporación tardía al sistema educativo y determinadas condiciones personales o de historia escolar. Estas realidades pueden generar dificultades de aprendizaje, comunicación y lenguaje, sin estar necesariamente vinculadas a una discapacidad. Desde una perspectiva inclusiva, la escuela debe proporcionar los apoyos y recursos específicos necesarios para favorecer el máximo desarrollo del alumnado.

Retraso madurativo

El Retraso Madurativo, denominado Retraso Global del Desarrollo (RGD) en el DSM-5, se refiere a niños menores de 5 años que no alcanzan los hitos esperados para su edad en diferentes áreas del desarrollo. Puede afectar a la motricidad, lenguaje y habla, funciones cognitivas, desarrollo personal y social y actividades de la vida cotidiana. Estos alumnos pueden aprender y desarrollar sus tareas, aunque a un ritmo más lento, por lo que es necesario respetar sus tiempos y proporcionar oportunidades de aprendizaje ajustadas a sus necesidades.

Altas Capacidades Intelectuales

Las Altas Capacidades Intelectuales (ACI) constituyen un concepto amplio y heterogéneo que incluye perfiles como la superdotación y el talento. El modelo de Castelló y Batlle contempla una capacidad intelectual global elevada, mientras que el talento puede ser simple, cuando destaca una aptitud específica, o complejo, cuando combina varias aptitudes. La concepción actual supera la consideración exclusiva del CI y contempla también factores como la creatividad, la dedicación y las características emocionales. La teoría de los tres anillos de Renzulli integra capacidad intelectual superior, alta dedicación a las tareas y creatividad; estos tres elementos aparecen representados conjuntamente en la figura de la página 8 del documento.

En el ámbito lingüístico, el alumnado con ACI puede presentar adquisición temprana del lenguaje, vocabulario amplio, comprensión del doble sentido y la ironía, lectura rápida, frases complejas, creatividad lingüística y correcta articulación. No obstante, pueden aparecer dificultades pragmáticas cuando sus intereses difieren de los de sus compañeros.

TDAH

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por inatención, hiperactividad e impulsividad, con repercusiones en las actividades sociales y académicas. El DSM-5 contempla tres presentaciones: predominantemente inatenta, predominantemente hiperactiva-impulsiva y combinada.

El alumnado con TDAH puede presentar dificultades para mantener y focalizar la atención, especialmente ante tareas poco motivadoras, así como problemas de velocidad de procesamiento, atención selectiva, dividida y alternante. También pueden existir dificultades en la memoria de trabajo, necesaria para mantener y manipular información mientras se realiza una tarea.

Desde Audición y Lenguaje son relevantes las dificultades de vocabulario, coherencia y cohesión discursiva, prosodia, articulación, escucha activa, expresión emocional y respeto de turnos conversacionales.

Incorporación tardía al sistema educativo

El alumnado con incorporación tardía puede presentar dificultades para alcanzar los objetivos y competencias respecto a sus iguales, especialmente cuando procede de otros países o se escolariza tardíamente. Entre las respuestas educativas destacan el apoyo idiomático y las aulas de acogida. El apoyo idiomático pretende superar la barrera lingüística y facilitar el acceso al currículo ordinario; las aulas de acogida favorecen la integración escolar y social, la adquisición de la lengua vehicular y el acceso progresivo a los aprendizajes curriculares.

Dificultades de acceso al sistema educativo

Pueden existir dificultades de acceso derivadas de absentismo, cambios frecuentes de residencia, condiciones socioculturales, problemas de salud, hospitalizaciones o dificultades del habla, lenguaje y comunicación. El documento señala como ejemplos retraso del lenguaje, disfemias, dislalias, disglosias y otros trastornos del habla. La respuesta debe adaptarse al origen de la dificultad y, cuando existe un trastorno comunicativo, aplicar las medidas de intervención correspondientes.

Idea clave: desde Audición y Lenguaje, la intervención con alumnado NEAE debe partir de una valoración individualizada de sus capacidades, necesidades comunicativas, características lingüísticas, ritmo de aprendizaje y contexto, proporcionando apoyos que favorezcan la participación, el aprendizaje y la inclusión educativa.

GLOSARIO

Altas Capacidades Intelectuales (ACI): Concepto amplio que engloba diferentes perfiles de elevada capacidad intelectual, entre ellos la superdotación y los distintos tipos de talento. Se caracteriza por una gran heterogeneidad.

Aula de acogida: Recurso organizativo y metodológico destinado a favorecer la acogida, integración escolar y social del alumnado inmigrante y su adaptación al sistema educativo. Facilita la adquisición de la lengua vehicular y los aprendizajes curriculares.

Apoyo idiomático: Medida educativa destinada a superar la barrera lingüística del alumnado no hispanohablante y facilitar su competencia comunicativa y acceso al currículo ordinario.

Atención alternante: Capacidad para cambiar el foco atencional entre diferentes tareas o estímulos. Puede presentar dificultades en el alumnado con TDAH.

Atención selectiva: Capacidad para focalizar la atención sobre determinados estímulos relevantes e inhibir otros. Puede estar alterada en el TDAH.

Atención voluntaria: Capacidad para mantener deliberadamente la atención durante una actividad. En el TDAH puede verse condicionada por las funciones ejecutivas y la motivación.

Cociente intelectual (CI): Medida tradicionalmente utilizada para valorar la capacidad intelectual. El documento señala que actualmente no debe considerarse el único criterio para identificar las altas capacidades.

Creatividad: Capacidad relacionada con la producción de respuestas y creaciones caracterizadas por la fluidez, flexibilidad y originalidad. Constituye uno de los tres elementos de la teoría de los tres anillos de Renzulli.

Disincronía: Desfase entre diferentes niveles de desarrollo, por ejemplo, entre el desarrollo intelectual y emocional, que puede aparecer en alumnado con ACI y generar dificultades de identificación y aprendizaje.

Disfemia: Dificultad del habla relacionada con la fluidez verbal; el documento la incluye entre las dificultades comunicativas que pueden afectar al acceso al sistema educativo.

Disglosia: Trastorno del habla asociado a alteraciones anatómicas o estructurales de los órganos implicados en la producción del habla. El documento la menciona entre las dificultades que pueden afectar al desarrollo de los patrones comunicativos.

Disincronía evolutiva: Desfase entre diferentes áreas del desarrollo que evolucionan a ritmos diferentes, especialmente relevante en determinados perfiles de altas capacidades.

Dislexia/disortografía: El documento no desarrolla estos trastornos en esta unidad; aparecen mencionados dentro del marco general de necesidades educativas contempladas por la normativa.

Dislalia: Dificultad en la articulación de determinados sonidos del habla. El documento la incluye entre los problemas de comunicación, habla y lenguaje que pueden repercutir en el acceso educativo.

Flexibilidad cognitiva: Capacidad para adaptar el procesamiento de la información y cambiar de estrategia o perspectiva. El alumnado con TDAH puede presentar menor flexibilidad cognitiva.

Incorporación tardía al sistema educativo: Situación del alumnado que se escolariza tardíamente y presenta dificultades para acceder a los objetivos y competencias básicas respecto a sus iguales.

Memoria de trabajo: Capacidad para mantener y manipular temporalmente la información necesaria para realizar una tarea y dirigir una conducta hacia un objetivo. Puede estar especialmente comprometida en el TDAH.

NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo): Conjunto de necesidades educativas que requieren una respuesta específica y diferente a la ordinaria. La LOMLOE incluye, entre otras, las asociadas al retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, atención, aprendizaje, altas capacidades, incorporación tardía y determinadas condiciones personales o de historia escolar.

Precocidad intelectual: Fenómeno evolutivo, cognoscitivo y emocional relacionado con la aparición temprana de recursos intelectuales durante el desarrollo, especialmente desde el nacimiento hasta los 14 años.

Retraso Global del Desarrollo (RGD): Denominación utilizada por el DSM-5 para referirse a niños menores de 5 años que no alcanzan los hitos esperados en diferentes áreas del desarrollo.

Retraso Madurativo: Retraso en la adquisición de uno o varios hitos del desarrollo respecto a lo esperado para la edad cronológica. Puede afectar a áreas motoras, lingüísticas, cognitivas, sociales y personales.

Superdotación intelectual: Perfil caracterizado por capacidad intelectual superior a la media en habilidades generales y específicas, acompañado, según el enfoque presentado en la unidad, de elementos como creatividad, dedicación y elevada productividad.

Talento complejo: Perfil de altas capacidades caracterizado por la combinación de varias aptitudes específicas elevadas. El documento ejemplifica el talento matemático como combinación de aptitud verbal, razonamiento lógico y gestión memorística.

Talento simple: Elevada aptitud o competencia en un ámbito específico, como el verbal, matemático, lógico o creativo.

TDAH: Trastorno del neurodesarrollo caracterizado por síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad que resultan inconsistentes con el nivel de desarrollo y repercuten en las actividades sociales y académicas.

Teoría de los tres anillos de Renzulli: Modelo que relaciona tres características fundamentales de la superdotación: capacidad intelectual superior a la media, alta dedicación a las tareas y creatividad.

Vulnerabilidad socioeducativa: Situación contemplada dentro del marco de las NEAE en la que determinadas condiciones sociales o educativas pueden generar barreras para el aprendizaje y el desarrollo del alumnado.

BIBIOLOGRAFÍA

Alsina, Á., y Sáiz, D. (2003). Un análisis comparativo del papel del bucle fonológico versus la agenda visoespacial en el cálculo en niños de 7-8 años. *Psichotema, 15* (2), 241-246.

Álvarez Suárez, M.P., Certuche Sierra, A.M., Javela Rugeles, C.E, López Álvarez, J.K (2019). Retraso global del desarrollo en la población pediátrica atendida en un hospital de tercer nivel del sur colombiano [Trabajo de grado, Universidad Surcolombiana]. Repositorio Universidad Surcolombiana. TH MD 0386.pdf (repositoriousco.co)

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5a ed.). Autor.

Aretxaga, L. (2013) *Orientaciones educativas. Alumnado con altas capacidades intelectuales*. Vitoria-Gasteiz, España: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Artigas, J., y Narbona, J. (2011*). Trastornos del neurodesarrollo*. Barcelona: Viguera.

Asociación Española de Superdotados y con talento para niños, adolescentes y adultos (2016). *Qué son las Altas Capacidades Intelectuales.* Recuperado 7 de marzo de 2021, de https://www.altascapacidadesytalentos.com/que-significa-tener-las-altas-capacidades/

Balbuena, F. (2016). La elevada prevalencia del TDAH: posibles causas y repercusiones socioeducativas. *Psicología educativa, 22*(2), 81-85.

Barkley, R.A. (2006). *Attention-deficit hyperactivity disorder: a handbook for diagnosis and treatment.* New York: Guilford Press.

Díaz, A., Jiménez, J.E., Rodríguez, C., Alfonso, M. y Artiles, C. (2013). Consideraciones de los estudios de prevalencia del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH). *Revista de Psicología y Educación, 8*(2), 155-170.

Enseñat, A. (2015). *Neuropsicología pediátrica*. Madrid: Síntesis.

Fuente, O. (2016). *Estrategias y pautas de intervención en alumnado con TDAH en el aula de lengua extranjera: el aprendizaje cooperativo*. Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Valladolid, Valladolid, España. Recuperado de: http://uvadoc.uva.es/handle/10324/19141

García, C., Estévez, A., y Junqué, C. (2001). Perfil de memoria en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. *Anuario de Psicología, 32* (4), 35-46.

Guerrero, R. (2016). *Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entre la patología y la normalidad.* Barcelona: Planeta.

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. . (LOMLOE). *Boletín Oficial del Estado,* núm. 340, de 30 de diciembre de 2020

López, J. C. (2012). *Didáctica para alumnos con altas capacidades*. Madrid: Síntesis.

López, S. I. M., & Valenzuela, B. G. E. (2015). Niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. *Revista Médica Clínica Las Condes*, *26*(1), 42-51.

Macià., D. (2012). *TDAH en la infancia y la adolescencia*. Madrid: Pirámide.

Mateos, R., Agudo, C., y Fernández, G. (2006). Atención educativa al alumnado con sobredotación intelectual . *Revista Digital Práctica Docente*, 3.

Ovalles, A. (2017). Teoría de los tres anillos como modelo de intervención educativa para el desarrollo de altas capacidades*. Revista encuentros*, 1(1), 119-128.

Sáez, E. M. (2021). *Proyecto de innovación para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de incorporación tardía al sistema educativo español*. Editorial Inclusión.

Sánchez, A. (2011). *Desarrollo psicoevolutivo del niño I.* GPS. Madrid, España: Formación Alcalá.

Sánchez, A. (2013). *Altas Capacidades Intelectuales: Detección, evaluación, diagnostico e intervención educativa*. Madrid, España: Formación Alcalá.

Schroeder, C., y Gordon, B. (2002*). Assessment and treatment of childhood problems*, New York: Guilford Press.

Torre, M. (2008). Alumnado inmigrante de incorporación tardía y enseñanza de lenguas: Los primeros pasos. *I Jornadas sobre Lenguas, Currículo y Alumnado Inmigrante*, *51*.

Vieites, T. (2019). Dificultades en atención y memoria en alumnado de Educación Primaria con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. *Revista de Psicología y Educación, 14*(2), 136-143.

Vijande Alonso, M. (5 de enero de 2021). Retraso global del desarrollo. MejorconSalud. https://mejorconsalud.as.com/retraso-global-del-desarrollo/